

Tema 4: Fragilidad y Valoración Funcional

1. Introducción y relevancia clínica

La **fragilidad** es uno de los conceptos centrales de la geriatría. No es una enfermedad, sino un **estado clínico caracterizado por la disminución de la reserva fisiológica y capacidad de adaptación**, lo que vuelve a la persona mayor **más vulnerable a presentar eventos adversos de salud**, incluso frente a estresores mínimos.

Una persona frágil puede **caer, hospitalizarse, perder autonomía** o incluso **morir** ante situaciones que serían menores en individuos sin fragilidad.

La fragilidad es:

- **Prevalente**: aumenta significativamente después de los 70 años.
- **Dinámica**: puede **progresar**, pero **también es reversible** si se interviene a tiempo.
- **Predictora** de discapacidad, institucionalización, hospitalización y mortalidad.

La **valoración funcional** es la herramienta fundamental para **detectar fragilidad y prevenir dependencia**. Por ello, es parte de la atención esencial en APS y requisito clave en EUNACOM.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La fragilidad surge por la interacción de factores relacionados con:

- **Envejecimiento biológico**,
- **Enfermedades crónicas** (especialmente cardiometabólicas y neurológicas),
- **Sedentarismo e inmovilidad**,
- **Malnutrición**,
- **Polifarmacia**.

El mecanismo central es la **sarcopenia**, entendida como:

- Disminución de la **masa muscular**,
- Disminución de la **fuerza muscular**,
- Disminución de la **performance física**.

Sarcopenia → disminución de fuerza → dificultad para moverse → inmovilidad progresiva → dependencia.

La fragilidad es un **continuo**:

Robusto → **Prefrágil** → **Frágil** → **Dependiente**

La intervención se orienta a **detener la progresión y recuperar función**.

3. Clínica (signos, síntomas, detección)

La fragilidad no siempre se expresa como una enfermedad aguda. Puede manifestarse como:

- Cansancio persistente,
- Lentitud al caminar,
- Dificultad para levantarse desde una silla,
- Pérdida involuntaria de peso,
- Disminución de actividad física,
- Episodios de caídas,
- Vulnerabilidad ante hospitalizaciones.

Criterios Fenotípicos de Fried (los más usados en investigación):

Una persona es **frágil** si presenta **≥ 3** de los siguientes:

Criterio	Indicador
Pérdida de peso involuntaria	>4,5 kg en 1 año
Fatiga / cansancio	"Me siento agotado la mayor parte del tiempo"
Fuerza disminuida	Preensión débil
Lentitud de la marcha	<0,8 m/s en 4–5 metros
Bajo nivel de actividad física	Sedentarismo

Pre-frágil: 1–2 criterios → *momento ideal para intervenir*.

4. Valoración funcional

La valoración funcional analiza **lo que la persona puede hacer en su vida cotidiana**, lo cual es más relevante que el diagnóstico biomédico aislado.

A) Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

Evalúan **autocuidado**:

- vestirse, alimentarse, continencia, baño, traslado, deambulación.

Escala más utilizada:

- **Índice de Barthel** (0 a 100 puntos).
 ≥ 90 autonomía, < 60 dependencia significativa.

B) Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)

Evalúan **autonomía en el entorno social**:

- manejar finanzas, compras, cocinar, uso de teléfono, transporte.

Escala:

- **Lawton-Brody** (0–8 en mujeres, 0–5 en algunos varones).
Detecta **pre-fragilidad**.

C) Velocidad de la marcha

Prueba simple, de enorme poder predictivo:

- Caminar **4 metros** a paso habitual.
- $\geq 1 \text{ m/s}$ → buen pronóstico.
- $< 0,8 \text{ m/s}$ → riesgo de fragilidad.
- $< 0,6 \text{ m/s}$ → riesgo de hospitalización y mortalidad.

D) Test “Timed Up and Go” (TUG)

Levantarse de silla, caminar 3 metros, volver y sentarse:

Resultado	Interpretación
$< 10 \text{ s}$	Normal
$10\text{--}20 \text{ s}$	Fragilidad

Resultado	Interpretación
>20 s	Alto riesgo de caídas

5. Tratamiento y manejo (MINSAL 2019)

El objetivo es **preservar o recuperar la autonomía funcional**.

A) Ejercicio físico multicomponente

Debe incluir:

- **Fortalecimiento muscular** (2–3 veces/semana),
- **Entrenamiento de equilibrio** (prevención de caídas),
- **Resistencia aeróbica** (caminar, bicicleta estática).

Es la intervención más efectiva y con evidencia más consistente.

B) Nutrición

- Ingesta proteica: **1,0–1,2 g/kg/día** (más alta en sarcopenia).
- Priorizar alimentos ricos en vitamina D y proteínas.
- Suplementar Vitamina D si existe déficit.

C) Revisión de medicamentos

- Evitar: benzodiacepinas, anticolinérgicos, neurolépticos típicos.
- Ajustar dosis según función renal.
- Reducir polifarmacia innecesaria.

D) Soporte social

- Evaluar cuidador y red domiciliaria.
- Derivar a programas de apoyo (APS, centros día, rehabilitación comunitaria).

E) Prevención y rehabilitación post-hospitalización

La hospitalización puede producir **pérdida funcional acelerada** si no se moviliza activamente.

En geriatría, “**cada día en cama = una semana para recuperar movilidad**”.

6. Complicaciones y pronóstico

Si no se trata, la fragilidad progresa a:

- Caídas y fracturas (especialmente cadera),
- Dependencia para ABVD,
- Institucionalización,
- Depresión y aislamiento,
- Mayor mortalidad.

Con intervención temprana:

- Se puede **detener la progresión**,
- Recuperar función,
- Disminuir riesgo de hospitalización,
- Sustentar un envejecimiento funcional positivo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

- Fragilidad **no se diagnostica por la edad**, sino por **función**.
- Velocidad de la marcha es un **signo vital geriátrico**.
- La pérdida funcional comienza en **AIVD**, no en ABVD → usar Lawton-Brody para pesquisarla.
- El ejercicio **fortalece y revierte sarcopenia**, no el reposo.
- La hospitalización sin movilización **acelera la fragilidad**.

Errores frecuentes

- Confundir fragilidad con demencia o depresión.
- Indicar reposo tras una caída “para evitar nuevas caídas”.
- Usar benzodiacepinas como “ayuda para dormir”.
- Medir sólo fuerza o sólo cognición → **se debe evaluar función**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **fragilidad** es un estado de vulnerabilidad debido a pérdida de reserva fisiológica.
 2. La **sarcopenia** es el mecanismo central que disminuye fuerza y autonomía.
 3. La **valoración funcional** es esencial: Barthel, Lawton, TUG y velocidad de la marcha.
 4. La fragilidad es **reversible**, especialmente en la etapa de **pre-fragilidad**.
 5. El **ejercicio multicomponente** es la intervención con mayor evidencia.
 6. Nutrición adecuada + revisión farmacológica son pilares del manejo.
 7. El objetivo clínico principal es **mantener independencia y calidad de vida**.
-